🏥 GUIA COMPLETO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

Nível USMLE Step 2 CK / Step 2 CS / Step 3 + Ivy League

Parte 2: Assistência ao Parto e Puerpério

📚 MÓDULO 12: TRABALHO DE PARTO

12.1 Conceito e Fisiologia

🎈 **Analogia**: O trabalho de parto é como abrir uma porta pesada de mola — o útero (a mola) contrai e empurra o bebê contra o colo (a porta). Cada contração empurra um pouco mais, e a porta vai abrindo devagar. Quando está totalmente aberta (10 cm), o bebê pode passar.

Definição clínica: Contrações uterinas regulares e progressivas que levam ao apagamento e dilatação do colo uterino, culminando na expulsão do concepto.

12.2 Diferenciação: Trabalho de Parto Verdadeiro vs. Falso (Braxton Hicks)

Característica	Verdadeiro	Falso (Braxton Hicks)
Regularidade	Regular, intervalos decrescentes	Irregular
Intensidade	Progressivamente crescente	Sem progressão
Localização	Dorso → abdome anterior	Apenas abdome anterior
Efeito da deambulação	Mantém ou intensifica	Alivia
Alteração cervical	SIM (dilatação + apagamento)	NÃO
Sedação	NÃO cessa	Cessa com sedação

12.3 As Fases do Trabalho de Parto

1º Período — Dilatação (o mais longo):

Subfase	Dilatação	Duração média	Características
Fase Latente	0 → 6 cm	Nulípara: até 20h; Multípara: até 14h	Contrações a cada 5-10 min, irregulares, leve desconforto
Fase Ativa	6 → 10 cm	Nulípara: ~6h; Multípara: ~3h	Contrações a cada 2-3 min, duração 45-60 seg, intensas

🎈 **Analogia**: A fase latente é como aquecer o motor do carro — demora, mas é necessária. A fase ativa é quando o carro pega a estrada — anda rápido e não para.

> NOTE
>
> **Definição atual (ACOG/Zhang, 2010)**: A fase ativa começa com **6 cm** (não mais 4 cm como na classificação de Friedman). Antes de 6 cm, a dilatação pode ser lenta sem indicar distocia. Isso é importante para evitar cesáreas desnecessárias.

2º Período — Expulsão:

- Do **dilatação completa (10 cm)** até o **nascimento**
- Duração: nulípara até **3h** (com analgesia) ou **2h** (sem); multípara até **2h** (com) ou **1h** (sem)
- A gestante sente vontade de "fazer força" (reflexo de Ferguson)

3º Período — Dequitação/Secundamento:

- Do nascimento até a **expulsão da placenta**
- Duração normal: até **30 minutos**
- Tipos de descolamento:
    - **Baudelocque-Schultze** (75%): face fetal primeiro, sangramento após → "mecanismo central"
    - **Baudelocque-Duncan** (25%): borda da placenta primeiro, sangramento durante → "mecanismo lateral"

4º Período — Greenberg (1ª hora pós-parto):

- Período de observação rigorosa

- Risco de **hemorragia pós-parto**
- Monitorar: tônus uterino (deve ser contraído = "globo de segurança de Pinard"), sinais vitais, sangramento

12.4 Mecanismo do Parto — Os 7 Movimentos Cardinais

🎈 **Analogia**: O bebê precisa fazer uma "dança" para passar pelo canal de parto, que é como um túnel curvo. Ele vira a cabeça e o corpo de várias maneiras para encontrar o melhor "encaixe" — como passar uma chave em uma fechadura, girando até achar a posição certa.

#	Movimento	O que acontece
1	**Insinuação (Encaixamento)**	A cabeça entra na pelve no diâmetro transverso ou oblíquo
2	**Descida**	A cabeça desce pelo canal de parto (pode ser simultânea)
3	**Flexão**	O queixo encosta no peito → apresenta o menor diâmetro (suboccipitobregmático = 9,5 cm)
4	**Rotação Interna**	O occipício gira de transverso para anterior (OA) → alinha com o diâmetro anteroposterior do estreito inferior
5	**Extensão**	A cabeça "desflexa" e emerge sob a sínfise púbica (occipício → face)
6	**Rotação Externa (Restituição)**	A cabeça gira de volta para alinhar com os ombros
7	**Expulsão**	Ombro anterior emerge sob a sínfise, depois o posterior, e o corpo desliza

> **TIP**
>
> **Mnemônico para USMLE**: "**E**very **D**ay **F**rank **I**nternal**ly** **E**xternally **E**xpels" → Engagement, Descent, Flexion, Internal rotation, Extension, External rotation, Expulsion

Estática Fetal — Termos Importantes:

Conceito	Definição
Situação	Relação entre o maior eixo fetal e o materno: **Longitudinal** (vertical) ou **Transversa**
Apresentação	Parte fetal que se apresenta ao estreito superior: **Cefálica** (95%), Pélvica (3-4%), Córmica (transversa)
Posição	Relação do ponto de referência fetal com o lado materno: **esquerdo (E)** ou **direito (D)**
Variedade de Posição	Relação do ponto de referência com a pelve: **OEA** (occipito-esquerda-anterior = mais comum)
Atitude	Grau de flexão/deflexão da cabeça

Apresentações Cefálicas por Grau de Deflexão:

Apresentação	Ponto de Referência	Diâmetro	Tamanho	Viabilidade
Fletida (Occipício)	Lambda (fontanela posterior)	Suboccipitobregmático	9,5 cm	✅ Parto vaginal
Defletida 1º grau (Bregma)	Bregma (fontanela anterior)	Occipitofrontal	12 cm	⚠️ Difícil
Defletida 2º grau (Fronte)	Glabela/nariz	Occipitomentoniano	13,5 cm	❌ Inviável via vaginal
Defletida 3º grau (Face)	Mento (queixo)	Submentobregmático	9,5 cm	✅ Se mento anterior

📑 MÓDULO 13: PARTOGRAMA

13.1 Conceito

🎈 **Analogia**: O partograma é como o "velocímetro" do parto. Ele mostra se o parto está andando na velocidade certa ou se está "travado". Se o tracinho do gráfico para de subir, é sinal de problema.

Definição: Registro gráfico do progresso do trabalho de parto (dilatação cervical x tempo), descida da apresentação e condições materno-fetais.

13.2 Estrutura do Partograma (OMS)

O partograma possui:

- **Eixo X**: tempo (horas)
- **Eixo Y**: dilatação cervical (cm) e descida da apresentação (planos de De Lee)
- **Linha de Alerta**: linha que marca o limite de progressão normal (1 cm/h a partir de 6 cm)
- **Linha de Ação**: paralela à linha de alerta, **4 horas** à direita → se a curva atingir esta linha, intervenção é necessária

13.3 Quando Iniciar o Preenchimento:

- A partir de **6 cm de dilatação** (início da fase ativa) — padrão OMS atual
- Registrar a cada **30-60 minutos**: dilatação, descida, FCF, PA materna, contrações, líquido amniótico

13.4 Interpretação — Padrões de Distocia:

Padrão	Definição	Causa provável
Parada de dilatação	Sem progressão de dilatação por ≥ 4h com contrações adequadas (ou 6h sem contrações adequadas)	DCP, apresentação anômala
Parada de descida	Sem progressão da descida por ≥ 2-3h (com ou sem esforço expulsivo)	DCP, macrossomia
Fase ativa prolongada	Dilatação < 1 cm/h (curva cruza linha de alerta)	Distocia funcional, iatrogenia

IMPORTANT

Para USMLE: Antes de diagnosticar **parada de progressão**, é necessário confirmar:

1. Dilatação ≥ 6 cm
2. Membranas rotas
3. ≥ 4 horas com contrações adequadas (≥ 200 MVU) OU ≥ 6 horas com contrações inadequadas com ocitocina Só então considerar cesárea por falha de progressão.

📚 MÓDULO 14: ANALGESIA E ANESTESIA OBSTÉTRICA

14.1 Conceito

🎈 **Analogia**: A dor do parto é como subir uma montanha muito íngreme. A analgesia é como ter um "elevador" que tira a dor, mas mantém a mamãe acordada e capaz de participar.

14.2 Métodos Não Farmacológicos:

- Deambulação, banho quente (chuveiro/banheira), bola de parto
- Massagem, acupuntura, aromaterapia
- Técnicas de respiração e relaxamento
- Suporte contínuo (doula, acompanhante)

14.3 Métodos Farmacológicos:

Método	Técnica	Vantagens	Desvantagens
Peridural (Epidural)	Cateter no espaço peridural (L3-L4 ou L4-L5)	Excelente analgesia, ajustável, mãe consciente	Hipotensão, retenção urinária, prolongar 2º período, cefaleia (se punção acidental da dura)
Raquidiana (Subaracnóidea)	Punção única no espaço subaracnóideo	Rápida, dose baixa	Duração limitada, cefaleia pós-punção
Combinada (Raqui-Peri)	Raquidiana + cateter peridural	Início rápido + possibilidade de manutenção	Maior complexidade técnica
Opióides sistêmicos	Meperidina, fentanil, remifentanil IV/IM	Fácil, acessível	Depressão respiratória neonatal, náusea, eficácia limitada
Bloqueio do pudendo	Infiltração do nervo pudendo (espinhas isquiáticas)	Bom para 2º período e episiotomia	Não alivia dor da contração

WARNING

Contraindicações à analgesia neuroaxial:

- Recusa da paciente
- Coagulopatia (plaquetas < 70.000-80.000)
- Infecção no local de punção
- Hipovolemia não corrigida

> - Pressão intracraniana elevada
> - Alergia aos anestésicos

14.4 Complicações da Analgesia Peridural:

Complicação	Mecanismo	Conduta
Hipotensão	Bloqueio simpático → vasodilatação	Pré-hidratação, efedrina/fenilefrina, DLE
Cefaleia pós-punção dural	Fístula liquórica → hipotensão intracraniana	Hidratação, cafeína; se persistir → **blood patch** peridural
Retenção urinária	Bloqueio da inervação vesical	Cateterismo vesical
Febre	Mecanismo não completamente esclarecido	Monitorar; descartar infecção
Bloqueio motor	Dose excessiva de anestésico local	Reduzir concentração

📑 MÓDULO 15: ASSISTÊNCIA AO PARTO HUMANIZADO

15.1 Princípios

🎈 **Analogia**: O parto humanizado é como deixar a natureza fazer seu trabalho, com respeito e carinho. Em vez de tratar o parto como uma "cirurgia", tratamos como um evento natural, intervindo apenas quando necessário.

15.2 Práticas Recomendadas (OMS 2018):

✅ RECOMENDADO	❌ NÃO RECOMENDADO
Acompanhante de escolha da mulher	Enema (lavagem intestinal)
Liberdade de posição e deambulação	Tricotomia (raspagem dos pelos)
Oferta de líquidos e alimentação leve	Amniotomia de rotina
Métodos não farmacológicos de alívio da dor	Episiotomia de rotina
Contato pele a pele imediato	Kristeller (pressão no fundo uterino)
Clampeamento tardio do cordão (1-3 min)	Aspiração de rotina do RN
Respeitar o plano de parto	Separação mãe-bebê sem indicação
Monitoramento intermitente da FCF	Monitorização contínua de rotina (baixo risco)
Partograma	Ocitocina de rotina na fase ativa

> CAUTION
>
> A **Manobra de Kristeller** (pressão no fundo uterino durante o expulsivo) é **CONTRAINDICADA**. Associada a: rotura uterina, descolamento de placenta, lesão fetal, inversão uterina.

15.3 Episiotomia:

- **Não deve ser rotineira** (uso seletivo/restritivo)
- Indicação principal: sofrimento fetal agudo com necessidade de abreviar o expulsivo
- Tipos:
  - **Mediana** (midline): menor sangramento, melhor cicatrização, MAS maior risco de lesão do esfíncter anal (3º/4º grau)
  - **Médio-lateral**: maior sangramento, mais dolorosa, MAS menor risco de extensão para o esfíncter anal → **PREFERIDA**

15.4 Clampeamento do Cordão:

- **Tardio (1-3 minutos)**: RECOMENDADO pela OMS
  - Benefícios: ↑ reservas de ferro no RN, ↑ volume sanguíneo, ↓ anemia nos primeiros meses
  - Exceções: RN em asfixia grave necessitando reanimação imediata
- **Precoce (< 1 min)**: apenas em situações específicas

📚 MÓDULO 16: PARTO VAGINAL — ASSISTÊNCIA PRÁTICA

16.1 Monitorização Intraparto

BCF (Batimentos Cardíacos Fetais):

- Ausculta intermitente a cada **15-30 min** na fase ativa do 1º período
- Ausculta a cada **5 min** no 2º período (ou após cada contração)
- Normal: 110-160 bpm

Contrações uterinas:

- Palpar a cada 30-60 min
- Avaliar: frequência, duração, intensidade
- Fase ativa adequada: 3-5 contrações em 10 min, duração 40-60 seg

16.2 Assistência ao Período Expulsivo

Posições de parto:

- **Litotômica** (tradicional): mais usada em hospitais, permite melhor visualização
- **Semi-sentada** (45°): mais confortável, usa a gravidade
- **Lateral (Sims)**: boa para controle de velocidade
- **De cócoras**: usa gravidade, amplia diâmetros pélvicos
- **Quatro apoios**: boa para variedades posteriores

Proteção perineal:

- Técnica de "hands on" ou "hands poised" (mãos prontas sem pressão ativa)
- Controlar a velocidade de desprendimento da cabeça
- Manobra de **Ritgen modificada**: pressão controlada sobre o períneo para extensão controlada da cabeça

16.3 Distócias

🎈 **Analogia**: Distocia = parto "travado". É como uma peça de quebra-cabeça que não encaixa no lugar. Pode ser porque a peça é grande demais (bebê grande), o buraco é pequeno demais (pelve estreita), ou a força de empurrar não é suficiente (contrações fracas).

Classificação das Distócias:

Distócia Funcional (das contrações):

Tipo	Problema	Conduta
Hipoatividade uterina	Contrações fracas/espaçadas	Amniotomia + ocitocina
Hiperatividade uterina (taquissistolia)	> 5 contrações em 10 min	Suspender ocitocina, tocolítico (terbutalina), DLE, O_2
Hipertonia uterina	Tônus basal elevado, útero não relaxa	Suspender ocitocina, tocolítico
Incoordenação uterina	Contrações arrítmicas, sem progresso	Analgesia peridural ± ocitocina

Distócia de Ombros — EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

🎈 **Analogia**: A cabeça do bebê nasceu, mas os ombros ficaram "presos" atrás do osso da mamãe (sínfise púbica). É como tentar tirar uma rolha de uma garrafa — a parte de cima saiu, mas o meio está preso.

Definição: Após o desprendimento da cabeça, há **necessidade de manobras adicionais** para liberar os ombros (além da tração suave e pressão no fundo)

Mnemônico "HELPERR" para manobras:

Letra	Manobra	Descrição
H	Help (pedir ajuda)	Chamar equipe, anestesista, neonatologista
E	Evaluate for Episiotomy	Considerar episiotomia ampla (não resolve a distocia óssea, mas dá espaço)
L	Legs — **McRoberts**	Hiperflexão das coxas sobre o abdome (retifica o sacro, aumenta diâmetro AP) — **1ª manobra a ser feita**
P	Pressure — **Rubin I**	Pressão suprapúbica (NÃO fúndica!) para deslocar o ombro anterior
E	Enter — **Rubin II / Wood**	Rotação do ombro posterior para posição oblíqua
R	Remove posterior arm	Capturar e extrair o braço posterior
R	Roll — **Gaskin**	Colocar a paciente de quatro apoios (se possível)

CAUTION

NUNCA fazer:

- Tração excessiva na cabeça → lesão do plexo braquial (paralisia de Erb-Duchenne: C5-C6)
- Manobra de Kristeller → rotura uterina
- Pressão **fúndica** → impacta mais o ombro

Complicações da distócia de ombros:

Fetais	Maternas
Lesão do plexo braquial (Erb: C5-C6; Klumpke: C8-T1)	Hemorragia pós-parto
Fratura de clavícula	Lacerações perineais 3º/4º grau
Fratura de úmero	Rotura uterina
Asfixia neonatal	Lesão vesical/retal
Óbito	

16.4 Parto Operatório (Fórceps e Vácuo-Extrator)

Indicações:

- Período expulsivo prolongado
- Exaustão materna
- Sofrimento fetal agudo no expulsivo
- Contraindicação ao esforço materno (cardiopatia, aneurisma cerebral)

Condições de aplicabilidade (todos devem estar presentes):

Condição	Requisito
Dilatação	**Completa (10 cm)**
Membranas	**Rotas**
Apresentação	**Cefálica**
Encaixamento	**Insinuada** (≥ plano 0 de De Lee para fórceps médio; ≥ +2 para fórceps de alívio)
Proporcionalidade	**Sem DCP**
Bexiga	**Vazia**
Anestesia	**Adequada**

16.5 Cesariana — Indicações

Absolutas	Relativas
Placenta prévia centro-total	Macrossomia (> 4.500g em diabética, > 5.000g sem DM)
Desproporção cefalopélvica (DCP) verdadeira	Apresentação pélvica
Prolapso de cordão com feto vivo	Iteratividade (2+ cesáreas prévias)
Situação transversa	Gemelares monoamnióticos
Herpes genital ativo (lesões)	Falha de indução
Parada de progressão (após critérios adequados)	HIV com CV > 1.000
Rotura uterina	
Sofrimento fetal agudo sem condições de parto vaginal imediato	
Vasa prévia	

📚 MÓDULO 17: TERCEIRO PERÍODO E HEMORRAGIA PÓS-PARTO

17.1 Manejo Ativo do 3º Período (RECOMENDADO pela OMS)

🎈 **Analogia**: Depois que o bebê nasce, a placenta precisa sair. O "manejo ativo" é como ajudar gentilmente — damos um remédio para o útero contrair forte (ocitocina), fazemos uma tração controlada no cordão e massageamos o útero para garantir que ele fique "duro como uma bola" e pare de sangrar.

As 3 etapas:

1. **Ocitocina 10 UI IM** (ou 5 UI IV lenta) imediatamente após o nascimento
2. **Tração controlada do cordão** (manobra de Brandt-Andrews): uma mão traciona o cordão e a outra segura o útero acima da sínfise (contratração)
3. **Massagem uterina** após a dequitação

> IMPORTANT
>
> O manejo ativo do 3º período **reduz em 60%** o risco de hemorragia pós-parto.

17.2 Hemorragia Pós-Parto (HPP)

Definição:

- **Parto vaginal**: perda sanguínea ≥ **500 mL** (ou ≥ 1.000 mL = HPP grave)
- **Cesárea**: perda sanguínea ≥ **1.000 mL**

Incidência: 5-10% dos partos → **principal causa de mortalidade materna no mundo**

Causas — Mnemônico dos "4 T's":

🎈 **Analogia**: Para lembrar por que a mamãe pode sangrar muito depois do parto, pense em 4 palavras com "T":

T	Causa	Frequência	Detalhes
Tônus (Atonia uterina)	O útero não contrai	**70%**	O útero "cansado" não aperta os vasos → sangra
Trauma	Lacerações, hematomas, rotura uterina, inversão uterina	20%	"Machucados" no canal de parto
Tecido (Restos placentários)	Placenta incompleta, acretismo	9%	Pedaços da placenta que ficaram → útero não contrai
Trombina (Coagulopatia)	CIVD, coagulopatias, uso de anticoagulantes	1%	O sangue não "coagula" direito

Manejo da HPP — Abordagem Escalonada:

> WARNING
>
> **Contraindicações da metilergometrina**:
>
> - **HAS/Pré-eclâmpsia** (risco de crise hipertensiva e AVC)
> - Usar misoprostol ou carbetocina como alternativa

Transfusão Maciça (se perda > 1.500 mL ou choque):

- Protocolo de transfusão maciça: **concentrado de hemácias : PFC : plaquetas = 1:1:1**
- **Ácido tranexâmico** 1g IV (dentro de 3h do início do sangramento) — reduz mortalidade (estudo WOMAN)

17.3 Acretismo Placentário

🎈 **Analogia**: Normalmente a placenta "gruda" no útero como um post-it — sai fácil. No acretismo, ela "gruda" como super cola — não sai, e tentar arrancar pode causar sangramento grave.

Grau	Profundidade	Conduta
Acreta	Aderida ao miométrio superficial	Pode tentar remoção manual + curetagem
Increta	Invade o miométrio	Histerectomia geralmente necessária
Percreta	Atravessa o miométrio, pode atingir bexiga/intestino	Histerectomia + reparo de órgãos adjacentes

Fatores de risco: cesáreas prévias + placenta prévia (principal), curetagens prévias, miomectomia

> CAUTION
>
> **Placenta prévia + cesárea anterior** = alto risco de **percretismo**. USG com Doppler + RNM para planejamento cirúrgico. O parto deve ser planejado em centro terciário com banco de sangue preparado.

📚 MÓDULO 18: PUERPÉRIO FISIOLÓGICO

18.1 Conceito e Fases

🎈 **Analogia**: Depois que o bebê nasce, o corpo da mamãe precisa "voltar ao normal" — é como arrumar a casa depois de uma grande festa. O útero diminui, os hormônios mudam, e o leite começa a ser produzido.

Fase	Período	Características
Puerpério imediato	1º ao 10º dia	Involução uterina rápida, lóquios, apojadura (descida do leite)
Puerpério tardio	11º ao 42º dia	Continuação da involução, cicatrização
Puerpério remoto	> 42 dias	Retorno da menstruação (se não amamentar), recuperação completa

18.2 Involução Uterina

Dia pós-parto	Altura do fundo uterino
Imediatamente	Cicatriz umbilical
1º dia	2 cm abaixo da cicatriz umbilical
10-12 dias	Não palpável acima da sínfise
6 semanas	Tamanho pré-gravídico

18.3 Lóquios (Sangramento Pós-Parto Normal)

Tipo	Cor	Período	Composição
Rubros (lochia rubra)	Vermelho-vivo	1-3 dias	Sangue, tecido decidual
Serosos (lochia serosa)	Rosado/amarronzado	4-10 dias	Soro, leucócitos
Albos (lochia alba)	Branco/amarelado	11-42+ dias	Leucócitos, muco cervical

> NOTE
>
> Lóquios com **odor fétido** ou retorno de lóquios **rubros** após cessar → suspeitar de **endometrite** (infecção puerperal).

18.4 Retorno da Fertilidade

Situação	Ovulação	Menstruação
Não amamentando	~6-8 semanas	~6-8 semanas
Amamentação exclusiva	Variável, pode ser > 6 meses	Variável

> TIP
>
> **LAM** (Lactational Amenorrhea Method): método contraceptivo se: amamentação exclusiva + amenorreia + < 6 meses pós-parto. Eficácia ~98%.

18.5 Contracepção no Puerpério

Método	Quando iniciar	Observações
DIU (cobre ou LNG)	Imediato (pós-placenta) ou 4-6 sem	Seguro na amamentação
Minipílula (progestágeno)	6 sem (ou imediato se não amamentar)	Compatível com amamentação
Implante (etonogestrel)	Imediato	Compatível com amamentação
Injetável trimestral (medroxiprogesterona)	6 sem	Compatível com amamentação
ACO combinado (estrogênio + progesterona)	**NÃO** antes de 6 sem (ou 6 meses se amamentar)	Risco de TVP + reduz produção de leite
Laqueadura tubária	Intracesárea ou 6+ sem	Decisão informada, ≥ 25 anos ou ≥ 2 filhos (Brasil)

📚 MÓDULO 19: ALEITAMENTO MATERNO

19.1 Importância

🎈 **Analogia**: O leite materno é como um "superpoder" — é o alimento perfeito feito sob medida para o bebê. É como se a mamãe tivesse uma "fábrica" que produz comida com anticorpos, vitaminas, e tudo que o bebê precisa. Nenhuma fórmula consegue copiar tudo isso.

19.2 Tipos de Aleitamento (OMS):

Tipo	Definição
Exclusivo	Apenas leite materno (pode incluir medicamentos/vitaminas) — recomendado até **6 meses**
Predominante	Leite materno + água/chás/sucos
Complementado	Leite materno + alimentos sólidos/semissólidos — dos **6 meses aos 2 anos ou mais**
Misto/Parcial	Leite materno + fórmula/outros leites

19.3 Fisiologia da Lactação

🎈 **Analogia**: A **prolactina** é o "cozinheiro" que faz o leite. A **ocitocina** é o "garçom" que serve o leite ao bebê. Quanto mais o bebê suga, mais o cozinheiro e o garçom trabalham.

19.4 Composição do Leite Materno

Tipo	Quando	Características
Colostro	Primeiros 3-5 dias	Amarelado, rico em **IgA secretora**, proteínas, leucócitos. Volume pequeno (suficiente!)
Leite de transição	5-14 dias	Aumenta volume, muda composição
Leite maduro	> 14 dias	Maior teor de gordura e lactose, volume pleno

19.5 Técnica de Amamentação — Pega Correta

Critério de pega correta	Descrição
Boca bem aberta	> 120°
Lábio inferior evertido	"Boca de peixe"
Aréola mais visível acima	Mais aréola acima da boca do que abaixo
Queixo tocando a mama	Contato próximo
Bochechas arredondadas	Sem covinha (covinha = pega errada, vácuo inadequado)
Sucção audível	Deglutição ouvida, sem estalos

19.6 Problemas Comuns da Amamentação

Problema	Causa	Conduta
Fissuras mamilares	Pega incorreta	Corrigir pega, leite materno no mamilo, lanolina
Ingurgitamento	Estase láctea	Esvaziar mamas (ordenha manual), compressas mornas antes e frias após, mamadas frequentes
Mastite	Infecção bacteriana (S. aureus)	ATB (cefalexina/dicloxacilina) + manter amamentação + analgesia + esvaziamento
Abscesso mamário	Complicação da mastite	Drenagem cirúrgica + ATB. Amamentar na mama contralateral; na ipsilateral se incisão longe da aréola
Candidíase mamária	Candida albicans	Nistatina/miconazol tópico na mama + tratar bebê
Baixa produção	Pega incorreta, frequência insuficiente, estresse	Livre demanda, técnica correta, hidratação, suporte emocional

IMPORTANT

A mastite NÃO é contraindicação para amamentação! Pelo contrário, manter a amamentação ajuda no esvaziamento e na resolução. Suspender apenas se abscesso com drenagem próxima à aréola.

19.7 Contraindicações Absolutas à Amamentação

Condição	Motivo
HIV materno (no Brasil)	Risco de transmissão vertical
HTLV-1 ou HTLV-2	Risco de transmissão
Galactosemia do RN	Incapacidade de metabolizar galactose
Uso materno de drogas ilícitas (cocaína, crack, anfetaminas)	Passam pelo leite
Quimioterapia/radioterapia	Citotóxicos no leite
Tuberculose ativa não tratada (suspender temporariamente)	Risco de transmissão respiratória; reiniciar após 2 sem de tratamento

📚 MÓDULO 20: COMPLICAÇÕES PUERPERAIS

20.1 Infecção Puerperal (Endometrite)

🎈 **Analogia**: Depois do parto, o interior do útero é como uma "ferida aberta" onde a placenta estava grudada. Se bactérias entrarem, causam infecção — como quando um corte no joelho inflama.

Definição: Febre ≥ 38°C em ≥ 2 medidas com intervalo de 4h, a partir de **24h pós-parto** (excluir as primeiras 24h, pois febre pode ser fisiológica)

Fatores de risco:

- **Cesárea** (principal fator de risco — 5-10x maior que parto vaginal)
- RPMO prolongada
- Trabalho de parto prolongado
- Múltiplos toques vaginais
- Corioamnionite
- Retenção de restos placentários

Etiologia: Polimicrobiana (E. coli, estreptococos, anaeróbios, Gardnerella)

Quadro clínico: Febre, dor à palpação uterina, lóquios fétidos/purulentos, útero subinvoluído, taquicardia

Tratamento: **Clindamicina 900 mg IV 8/8h + Gentamicina 5 mg/kg/dia IV** (esquema "gold standard" para endometrite pós-cesárea)

- Se não melhorar em 48-72h → considerar abscesso pélvico, tromboflebite pélvica séptica, ou ampliar espectro com ampicilina (cobrir Enterococcus)

20.2 Tromboembolismo Venoso (TVP/TEP)

Fatores de risco no puerpério:

- Cesárea (especialmente de emergência)
- Imobilização
- Obesidade
- Pré-eclâmpsia
- Hemorragia com transfusão
- Trombofilias

Diagnóstico:

- **TVP**: dor + edema unilateral em MMII → USG Doppler venoso
- **TEP**: dispneia súbita + taquicardia + dor torácica pleurítica → angio-TC de tórax

Tratamento: Anticoagulação com **heparina (não fracionada ou HBPM)** → seguras na amamentação

Profilaxia: HBPM (enoxaparina 40 mg SC/dia) em pacientes de risco por 6 semanas pós-parto

20.3 Depressão Pós-Parto

🎈 **Analogia**: Muitas mamães ficam tristes nos primeiros dias após o parto — isso se chama "baby blues" e é normal (afeta 50-80%). Mas se essa tristeza fica muito forte, dura mais de 2 semanas e impede a mamãe de cuidar do bebê, é depressão pós-parto — precisa de ajuda profissional.

Condição	Início	Duração	Gravidade	Conduta
Baby blues	2-3 dias	Até 2 semanas	Leve (choro, irritabilidade, ansiedade)	Suporte, reassegurar
Depressão pós-parto	2 sem - 12 meses	Semanas-meses	Moderada-grave (tristeza profunda, anedonia, culpa, insônia, pensamentos de morte)	Psicoterapia + antidepressivos (ISRS: sertralina é segura na amamentação)
Psicose puerperal	Primeiras 2 semanas	Variável	Grave (delírios, alucinações, agitação, risco de infanticídio/suicídio)	**EMERGÊNCIA**: internação psiquiátrica + antipsicóticos + estabilizadores de humor

> CAUTION
>
> **Psicose puerperal** é uma **emergência psiquiátrica**. Risco de infanticídio e suicídio. Ocorre em 1-2/1.000 partos, mais comum em transtorno bipolar. Nunca deixar a mãe sozinha com o bebê até estabilização.

Rastreio: Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh (EPDS) — aplicar em todas as puérperas. Score ≥ 13 → rastrear ativamente

20.4 Outras Complicações Puerperais

Complicação	Características	Conduta
Subinvolução uterina	Útero maior que o esperado, sangramento prolongado	Investigar restos placentários (USG), uterotônicos
Deiscência de episiotomia/cesárea	Abertura da sutura, dor, secreção	Limpeza, ATB, ressutura (se necessário)
Hematoma de parede/vulvar	Dor intensa, massa palpável	Drenagem cirúrgica se volumoso
Síndrome de Sheehan	Necrose hipofisária por hemorragia grave → agalactia, amenorreia, hipotireoidismo, insuficiência adrenal	Reposição hormonal
Inversão uterina	Fundo uterino se invagina → choque + massa na vagina	Reposição manual (manobra de Johnson) + uterotônicos depois
Retenção urinária	Frequente após peridural	Cateterismo vesical

NOTE

Síndrome de Sheehan: "A mamãe que sangrou muito no parto e depois o leite não desceu, a menstruação não voltou, e ela sente muito cansaço." → necrose da hipófise anterior. O 1º sinal geralmente é **agalactia** (não produz leite).

📋 HIGH-YIELD REVIEW — MÓDULO PARTO E PUERPÉRIO

IMPORTANT

⭐ Top 20 High-Yield Points para USMLE

1. **Fase ativa**: começa com **6 cm** (critério atual ACOG), não mais 4 cm.
2. **Parada de progressão**: ≥ 6 cm + membranas rotas + 4h contrações adequadas (ou 6h sem).
3. **Desaceleração tardia** = insuficiência uteroplacentária; **variável** = compressão de cordão.
4. **Manobra de McRoberts** = 1ª manobra na distócia de ombros (hiperflexão das coxas).
5. **HPP**: causa mais comum = **atonia uterina** (70%).
6. **4 T's** da HPP: Tônus, Trauma, Tecido, Trombina.

7. **Ácido tranexâmico**: 1g IV em ≤ 3h → reduz mortalidade na HPP (WOMAN trial).
8. **Manejo ativo do 3º período**: ocitocina + tração controlada + massagem uterina.
9. **Ocitocina**: contraindicada em hipertonia uterina e taquissistolia.
10. **Metilergometrina**: contraindicada na **hipertensão**.
11. **GBS**: profilaxia com penicilina G IV ≥ 4h antes do parto.
12. **Episiotomia médio-lateral**: preferida (menor risco de extensão até esfíncter anal).
13. **Clampeamento tardio** (1-3 min): recomendado pela OMS.
14. **Endometrite**: cesárea é o principal fator de risco. Tto: clindamicina + gentamicina IV.
15. **TEP no puerpério**: heparina é segura na amamentação. Warfarina também.
16. **Baby blues**: normal, até 2 sem. **Depressão pós-parto**: > 2 sem, precisa de tratamento.
17. **Psicose puerperal**: emergência! Risco de infanticídio. Internação imediata.
18. **Síndrome de Sheehan**: panhipopituitarismo pós-HPP grave. 1º sinal: agalactia.
19. **Prolactina produz, ocitocina ejeta** leite. Sucção é o principal estímulo.
20. **Mastite**: NÃO parar de amamentar! ATB + esvaziar mama + analgesia.